Co-funded by
European Union
Humanitarian Aid

World Health
Organization

انجمن علمی روانپزشکان ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

خودمراقبتی

انجمن علمی روانپزشکان ایران

با همکاری دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، و سازمان جهانی بهداشت

منابع اصلی استرس کارکنان نظام سلامت

- ترس از یا مواجهه با آسیب دیدن یا مرگ خود یا عزیزان
- فشارهای ناشی از دوری از خانواده
- در معرض اخبار نگران کننده یا حوادث بودن
- مسئولیت‌های شغلی سنگین و فشارهای کاری مداوم
- احساس ناامنی و بی اعتمادی به آینده

خودمراقبتی

روش های موثر برای خودمراقبتی

- پایش مستمر وضعیت خود و همکاران
- شرکت در سوپرویژن حرفه‌ای
- شرکت در گروه های مشورتی همکاران

پایش مستمر وضعیت خود و همکاران

- خودآگاهی نسبت به نشانه‌های فشار مزمن یا فرسودگی
- توجه به نیازهای پایه مانند خواب، تغذیه، استراحت، و وقفه‌های کوتاه در کار

توجه به وضعیت خود و همکاران

- خستگی مفرط
- تحریک‌پذیری
- کاهش تمرکز
- بی‌حسی هیجانی
- اختلال خواب، حساس درماندگی

شرکت در سوپرویژن

سوپرویژن کمک می‌کند تا:

- تجربه‌های دشوار و تنش‌زا را پردازش کنیم.
- مرزهای حرفه‌ای خود را بازبینی و تقویت کنیم.
- واکنش‌های هیجانی شخصی را شناسایی و تنظیم کنیم.
- فضایی امن برای بازاندیشی حرفه‌ای فراهم کنیم.
- فضایی برای بازاندیشی درباره موقعیت‌های پیچیده اخلاقی فراهم کنیم.

گروه های مشورتی همکاران

- امکان تبادل تجربه و کاهش احساس انزوا
- فرصتی برای:
  - دریافت بازخورد غیرقضاوتی
  - همفکری درباره چالش‌های بالینی
  - بازسازی حس همبستگی حرفه‌ای

روش های موثر برای خودمراقبتی

- تنظیم مرزهای حرفه‌ای
- شناخت محدودیت‌ها و پذیرش حدود اثرگذاری
- حفظ حس کارآمدی از طریق توجه به دستاوردهای روزانه
- تنظیم نگرانی‌های مزمن

شناخت محدودیت‌ها و پذیرش آنها

- تفکیک میان آنچه در حوزه اثرگذاری درمان‌گر قرار دارد و آنچه خارج از کنترل اوست.

- پذیرش محدودیت‌های فردی نشانه ناکارآمدی نیست.

توجه به دستاوردهای روزانه

- احساس تاثیرگذار نبودن می‌تواند منجر به احساس فرسودگی گردد.
- به رسمیت شناختن تلاش‌های کوچک روزمره به حفظ حس کارآمدی کمک میکند.

تنظیم نگرانی‌های مزمن

- اشتغال ذهنی مداوم با تهدیدها، اخبار، یا نگرانی‌های آینده منبعی برای فرسودگی
- تکنیک "زمان نگرانی"

تنظیم مرزهای حرفه ای

در مواقع بحران لازم است متخصص سلامت روان:

- چارچوب زمانی و احساسی خود را به‌روشنی مشخص کند؛
- از در دسترس بودن مداوم و پاسخ‌گویی بی‌وقفه پرهیز کند؛
- مسوولیت بحران‌های ساختاری یا تصمیم‌های کلان را بر عهده نگیرد.

تنظیم مرزهای حرفه ای

حفظ مرزها نشانه بی‌تفاوتی نیست، بلکه شرط تداوم حضور حرفه‌ای و

پایدار است.

ملاحظه‌های فرهنگی، حرفه‌ای و اخلاقی

ملاحظه‌های فرهنگی، حرفه‌ای و اخلاقی

- انطباق فرهنگی
- حفظ مرزهای حرفه‌ای
- حفظ محرمانگی
- بی‌طرفی و پرهیز از سوگیری

انطباق فرهنگی

- احترام به حساسیت‌های مذهبی و اعتقادات
- توجه به باورهای فرهنگی و خرده فرهنگ‌ها
- این توجهات در زمینه نوع لباس پوشیدن و ظاهر، تا میزان تماس چشمی و فاصله فیزیکی مورد نظر باشد.

حفظ مرز حرفه‌ای هنگام اجرا

- پرهیز از صمیمیت بیش از حد، وابستگی عاطفی یا ورود به روابط غیرحرفه‌ای
- پرهیز از تماس‌های غیرضروری خارج از چارچوب درمانی

علائم هشدار نقض مرز حرفه‌ای

- احساس می‌کنم این فرد بیش از دیگران نیاز به کمک دارد.
- خارج از چارچوب توافق شده ارتباط مکرر برقرار می شود.
- اطلاعات مراجع با همکاران یا مدیران، به صورت غیرضروی مطرح می‌شود.
- اشتغال ذهنی زیادی با مراجع ایجاد شده است.

حفظ حدود محرمانگی

- روشن باشد که اطلاعات مربوط به آسیب به خود یا دیگری از محرمانگی خارج است.
- شیوه ثبت اطلاعات و آمار غیرشخصی و کلی است.
- موارد مطرح شده در جلسات خارج از جلسه طرح نخواهد شد.

رضایت اگاهانه برای شرکت در برنامه

- توضیح این که شرکت در مداخله اجباری نیست.
- توضیح این که عدم شرکت پیامدی شغلی برای فرد ندارد.
- نحوه ثبت و نگهداری و استفاده از اطلاعات روشن شود.

بی‌طرفی و پرهیز از سوگیری

- شفاف کردن نقش تسهیلگر / مشاور با مدیر؛ ارزیاب عملکرد یا ناظر اداری
- مشخص کردن اهداف و محدودیت‌های مداخله.
- حدود ارتباط تسهیلگر با مدیریت را باید روشن کرد.
- مشخص کردن این که تسهیلگر نماینده منافع مدیریت نیست.

ارجـــاع

موارد نیازمند به ارجاع

- افکار آسیب‌به‌خود یا خودکشی
- سایکوز (روان‌پریشی) حاد
- تشدید پیش‌رونده علامت‌های اضطرابی یا افسردگی، یا سوگ پیچیده (وجود افکار خودکشی یا احساس گناه زیاد نسبت به متوفی)
- ناتوانی شدید و پایدار در عملکرد
- بیماری زمینه‌ای روان‌پزشکی

اقدامات ضروری هنگام ارجاع

- ارزیابی خطر خودکشی:
  - پرسش مستقیم درباره افکار آسیب به خود
  - سابقه قبلی اقدام به خودکشی
  - وجود برنامه، دسترسی به ابزار و میزان حمایت

اقدامات ضروری هنگام ارجاع

- حفظ ایمنی بیمار، عدم رها کردن فرد به تنهایی
- معرفی منابع درمانی ایمن و در دسترس
- مستندسازی با رعایت محرمانگی و در چارچوب قانون
- مشورت با همکار ارشد در صورت نیاز